

8A. Tobillo-pie: anamnesis dirigida

Pedir que señale con un dedo el máximo dolor y relacionarlo con primeros pasos, terreno, calzado, carrera y traumatismo.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele el talón medial en los primeros pasos de la mañana o tras estar sentado?	Fasciopatía plantar.	Reduce patrón típico, no la excluye.	Palpación tubérculo medial, Windlass y dorsiflexión.
¿Le duele o está rígido el Aquiles al correr, saltar o ponerse de puntillas?	Tendinopatía aquilea.	Reduce Aquiles como generador principal.	Palpación, heel rise y ecografía; Thompson si trauma.
¿Ha tenido esguinces repetidos o inseguridad en terreno irregular?	Inestabilidad lateral crónica.	Reduce inestabilidad sintomática.	Cajón anterior, talar tilt, peroneos y propiocepción.
¿Le duele por dentro y nota que el arco se hunde o no puede ponerse de puntillas?	Disfunción del tibial posterior.	Reduce insuficiencia avanzada.	Heel rise monopodal, too-many-toes y ecografía.
¿Tiene dolor profundo anterior, rigidez, derrame, bloqueo o catching tras un esguince?	OA, impingement o lesión osteocondral.	Reduce generador articular mecánico.	Lunge, ROM, RX en carga y RM si bloqueo/OLT.
¿Nota quemazón u hormigueo en la planta o detrás del maléolo medial?	Túnel tarsal o dolor neural; considerar S1.	Reduce neuropatía tibial, no la excluye.	Tinel tarsal, neuro S1 y ecografía de nervio/masas.
¿El dolor eléctrico está entre los dedos y empeora con calzado estrecho?	Neuroma interdigital/Morton.	Reduce neuroma clínico.	Mulder, squeeze y diferenciar bursitis/MTP.
¿Aumentó de golpe la carga y ahora tiene dolor óseo focal que progresa?	Fractura por estrés.	Reduce estrés, pero una RX inicial normal no lo excluye.	Carga focal, Ottawa si trauma y RM ante alta sospecha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

En trauma aplicar reglas de Ottawa. El primer paso matutino orienta a fascia; terreno irregular a inestabilidad/subtalar; bloqueo profundo tras esguince obliga a pensar en lesión osteocondral.

8B. Tobillo-pie: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Cajón anterior	Rodilla flexionada, tobillo ligera flexión plantar; estabilizar tibia y traccionar calcáneo hacia delante.	Traslación/laxitud o tope blando frente al lado sano: lesión ATFL/inestabilidad lateral.	Reduce inestabilidad importante; en fase aguda dolor/defensa pueden falsearlo.
Talar tilt	Estabilizar tibia y aplicar inversión del retropié, comparando lados.	Mayor inclinación/laxitud: lesión CFL ± complejo lateral.	No excluye esguince parcial; comparar siempre lados.
Squeeze sindesmosis	Comprimir tibia y peroné juntos en tercio medio de pierna.	Dolor distal sobre sindesmosis: apoya esguince alto.	No lo excluye; combinar con rotación externa y mecanismo.
Rotación externa	Rodilla 90°, estabilizar pierna y rotar externamente el pie en neutro/dorsiflexión.	Dolor sindesmótico o medial: sospechar sindesmosis/deltoideo.	No excluye lesión parcial; imagen si persiste o carga imposible.
Thompson	Prono, pies fuera de camilla; comprimir masa gemelar observando flexión plantar.	Ausencia o clara reducción de flexión plantar: rotura de Aquiles hasta demostrar lo contrario.	Flexión conservada reduce rotura completa, pero no excluye parcial.
Heel rise monopodal	Elevar talón repetidamente sobre una pierna observando altura, dolor e inversión del retropié.	Incapacidad/dolor medial o no inversión: disfunción tibial posterior; dolor Aquiles orienta tendón.	No excluye tendinopatía leve; cuantificar repeticiones y comparar.
Windlass	En carga o sentado, dorsiflexionar pasivamente el hallux y palpar fascia.	Reproduce dolor medial de talón/tensa fascia: apoya fasciopatía plantar.	No excluye; la historia de primeros pasos sigue siendo clave.
Tinel tarsal	Percutir nervio tibial detrás del maléolo medial.	Parestesias hacia planta en distribución habitual: apoya túnel tarsal.	No excluye; explorar S1, tibial posterior y causas locales.
Mulder	Comprimir metatarsianos y pinzar espacio interdigital dorsal-plantar.	Clic/dolor eléctrico localizado hacia dedos: apoya neuroma interdigital.	No excluye; descartar bursitis intermetatarsal, MTP y metatarsalgia.

SÍNTESIS CLÍNICA

En trauma agudo aplicar reglas de Ottawa antes de asumir 'esguince'. Un test ligamentario negativo precoz puede ser falso por dolor o defensa: reexplorar. Dolor focal óseo progresivo con RX normal mantiene la sospecha de fractura por estrés.

8C. Tobillo-pie: ecografía, bloqueos y plan

La ecografía define tendón, fascia, ligamento, derrame y nervio superficial; no excluye lesión osteocondral ni fractura por estrés.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso anterior / articulación	Sin derrame/sinovitis; cortical y osteofitos visibles; impingement dinámico si procede.
Ligamentos laterales	ATFL/CFL continuos y tensos; comparación dinámica si está indicada.
Tendones	Aquiles, peroneos, tibial posterior, flexores y extensores: fibrillaridad, grosor, vaina y estabilidad dinámica.
Fascia plantar	Grosor y ecotextura en origen, sin rotura; correlación focal. Evitar diagnosticar solo por milímetros.
Nervios / antepié	Tibial y ramas, espacio interdigital, bursas y masas; Doppler cuando aporte.

Escenario	Plan	Límite
Fasciopatía plantar	Estiramiento fascia/gemelo, fuerza pie-tobillo, taping/ortesis seleccionada; ESWT si crónica.	Corticoide solo excepcional y ecoguiado: riesgo de rotura/atrofia grasa.
Aquiles	Carga mecánica progresiva excéntrica o pesada-lenta; adaptar insercional.	No infiltrar corticoide intratendinoso; rotura → derivación.
OA tobillo	Calzado/ortesis, fuerza, peso y actividad; infiltración con anestésico ± corticoide seleccionada.	AAOS 2026 desaconseja HA sola (fuerte) y PRP (moderada) en OA sintomática.
Articulación / vaina / neuroma	Bloqueo ecoguiado diagnóstico si el resultado cambia tratamiento; infiltración terapéutica individualizada.	Registrar tarea antes/después; evitar lesión neural/tendinosa y series automáticas.

MENSAJE AL PACIENTE

El objetivo es recuperar tolerancia a caminar y cargar. Las ondas pueden ayudar en algunas tendinopatías crónicas, pero el tratamiento central sigue siendo dosificar carga, fuerza y calzado.

8D. Tobillo-pie: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Dolor periférico	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días; reevaluar si persiste después de 7 días.
Brote articular	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Tendinopatía	La medicación no sustituye carga; usar analgesia solo si permite caminar y rehabilitar.	Plan de carga 8-12 semanas.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Tibiotalar	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20-40 mg + lidocaína 1%/bupivacaína 0,25%.	Total 3-5 mL; no usar HA/PRP de rutina en OA de tobillo.
Subtalar	Betametasona depot 0,5 mL o triamcinolona 10-20 mg + anestésico local.	Total 2-3 mL; confirmar articulación.
Morton	Betametasona depot 0,25-0,5 mL o triamcinolona 10 mg + lidocaína 1%.	Total 1-2 mL; evitar placa plantar y paquete neurovascular.
Túnel tarsal	Lidocaína 1% o ropivacaína 0,2%; sin corticoide de rutina.	2-4 mL perineural; no intraneural.
Fascia plantar	Si excepcional: triamcinolona 10 mg + lidocaína 1%.	Total 1-2 mL superficial a fascia; riesgo de rotura/atrofia.

REHABILITACIÓN

Fuerza pie-tobillo, gemelo/sóleo, fascia, propiocepción y calzado durante 8-12 semanas; 4-8 sesiones según déficit. ESWT si fascia/Aquiles crónicos.

EVITAR

Corticoide intratendinoso en Aquiles, punción plantar repetida, infiltrar sospecha de fractura por estrés u ofrecer HA/PRP como estándar de OA de tobillo.